

고형암의 목적과 시점에 따른 구분

근치적 항암요법 (Curative, Definitive)

수술적 절제 없이 완치의 목적으로 시행되는 요법

주로, 식도암, 두경부암, 항문암

01

선행 항암요법 (Neoadjuvant)

종양의 크기를 줄여 수술부위를 확보하고, 정상기관의 구조적 손상을 최소화하기 위해 수술 전 항암을 진행

1. 선행 방사선화학요법

연번	항암요법
1	fluorouracil + leucovorin + RT (개정 제2021-129호: 2021.5.1.)

02

보조 항암요법 (Adjuvant)

외과적 절제 후 잔류 악성질환의 임상적, 방사선학적 or 병리학적 근거가 없는 환자에게 시행, 국소 전신재발을 줄여 생존기간 연장 목적으로 시행

3. 수술 후 보조요법 (adjuvant)

연번	항암요법	대상	
	oxaliplatin + leucovorin + (infusional) fluorouracil (FOLFOX)	결장, 직장암	가. 수술 후 위험이 나. 수술 후

03

완화 항암요법 (Palliative)

진행성 또는 전이성 암 환자에서 완치가 어려운 경우, 증상 조절과 생존기간 연장, 삶의 질 향상을 목적으로 시행하는 치료입니다.

4. 고식적요법 (palliative)

가. 투여 단계: 1차 (first-line)

연번	항암요법
	irinotecan + leucovorin + (infusional)

04

혈액암의 목적에 따른 구분

관해유도요법 (Induction)

관해상태로 만드는 초기치료

arsenic trioxide + tretinoin (제2024-264호: 2024.12.1.)	18세 이상 염색체검사[t(15:17)전좌] 및/또는 유전자검사(PML/RAR- α)유전자로 새롭게 진단된 저위험(백혈구 수 $\leq 10 \times 10^9/L$) 급성전골수구성백혈병	1차	관해유도요법, 관해공고요법
--	---	----	-------------------

01

관해공고요법 (Consolidation)

관해상태에 추가 치료를 시행하여, 완
치에가깝게 만드는 치료

02

관해유지요법 (Maintenance)

관해상태를 유지하기 위해 시행하는 치
료

도 또는 고위험군 nt(HMA) 사용 이 없는 경우	-	관해유지요법
------------------------------------	---	--------

03

관해 (Remission)

현재 검사방법에서 더 이상 백혈병 세
포를 찾을 수 없는 상태

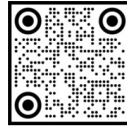
04

전신항암치료의 종류와 특징



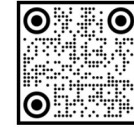
**1세대
세포독성항암제**

암세포와 정상세포를
구분하지 않고 공격



**2세대
표적항암제**

암세포만 선택적으로 공격



**3세대
면역항암제**

몸의 면역체계 활용

Mutation(돌연변이) 검사란?

암의 유전자 변이를 분석해서, 가장 효과적인 표적치료를 선택하고 예후와 치료 전략을 결정하기 위해 시행하는 검사



Mutation



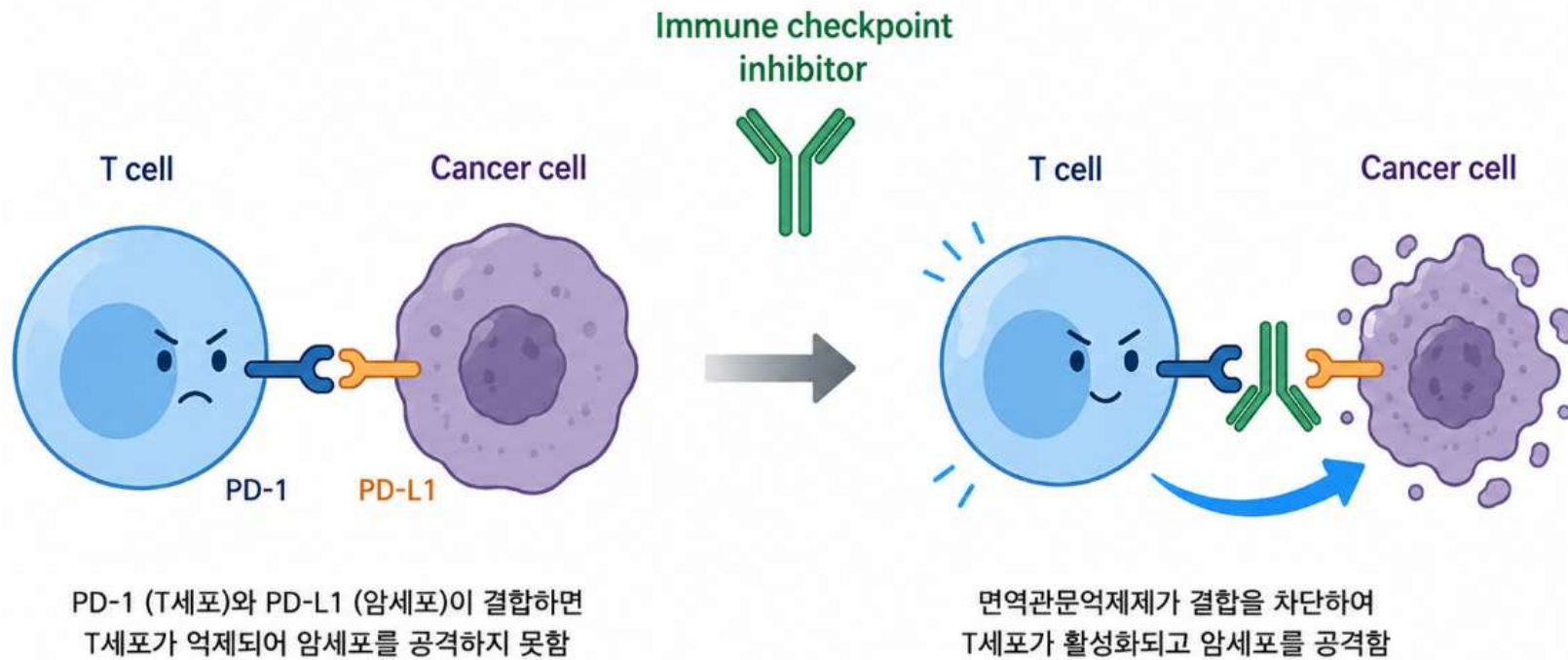
Targeted Therapy



Response ↑

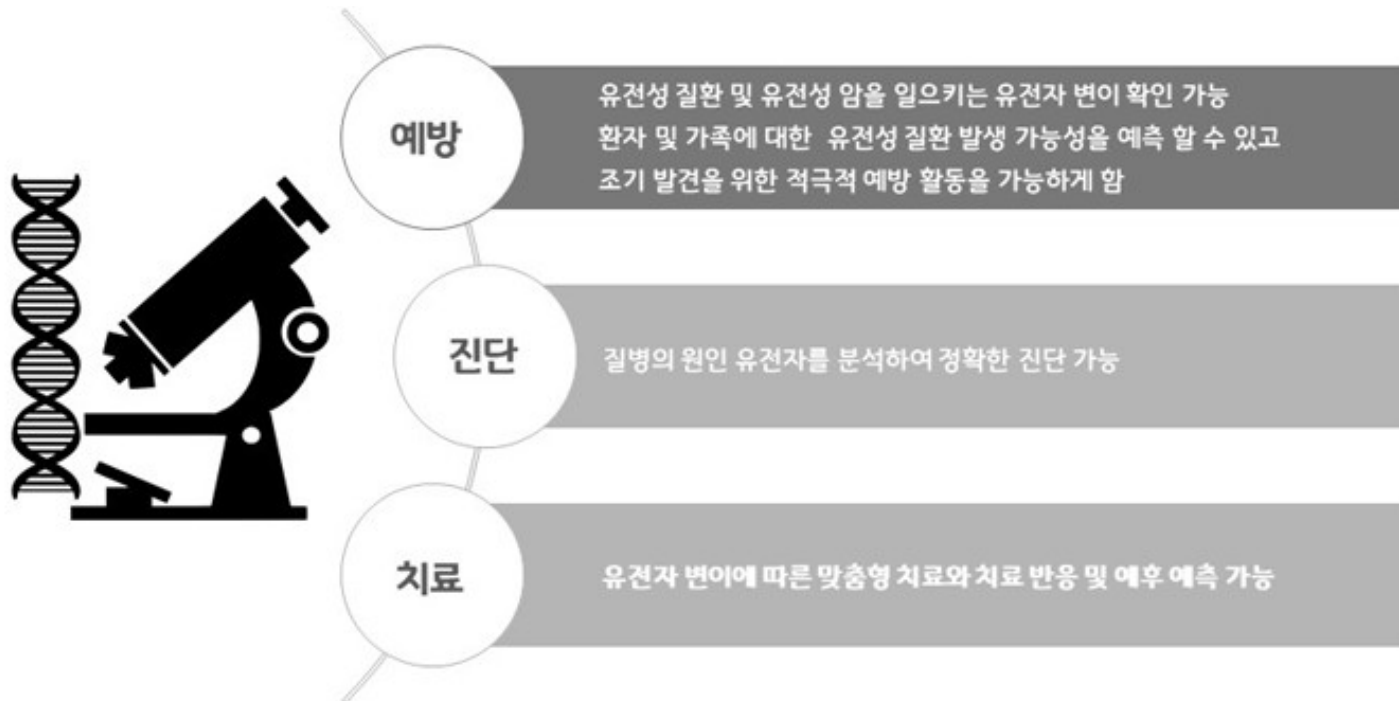
Immune checkpoint inhibitor 검사란?

암세포 표면의 PD-L1 단백질 발현율을 측정하여 면역항암제(PD-1/PD-L1 억제제) 치료 효과를 예측하는 조직 검사



NGS(차세대 염기서열) 검사란?

차세대 염기서열 분석기법은 대량의 유전체 염기서열을 무수히 많은 조각으로 만들어 각 조각을 동시 다발적으로 염기서열을 분석하여 **유전자 변이로 인한 질병을 진단 및 예측하고, 각 개인에게 맞는 치료제 선택을 돕는 검사**



반응평가

* 종양반응평가 (Tumor Response Criteria)

WHO 기준과, RECIST 기준이 있음. 현재는 RECIST가 주로 사용됨

완전 반응
CR
(Complete response)

병변이 완전히 사라짐.
(4주 후 재확인 필요)

부분 반응
PR
(Partial response)

30% 감소
(4주 후 재확인 필요)

안정 병변
SD
(Stable disease)

PR과 PD 기준의 중간

악화 PD
(Progressive disease)

20% 이상 크기증가 혹은 새로운 병변 발생
(전에 CR, PR 또는 SD가 확인되지 않았을 때)



PD일 경우 항암요법 변경